جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : جميله عبدالرحمن عبدالعال غنيم
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** عين شمس **العنوان :** ~~
رقم البطاقة : 26207030101946 **رقم التليفون :** 01003677380 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 18-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 03-07-1962 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي العلاج المساعد لوقاية العظام للمرضي الذين يتلقوا علاج هرموني حمض الزيلودرونيك [14157] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: جميله عبدالرحمن عبدالعال غنيم
National ID: 26207030101946

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Zoledronic acid for bone protection during hormonal therapy

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





National ID – Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان

MDT form

A-Patient ID:
1- Name : وجيله عبدالرحمن عبدالعال غنيم Ser: Female
3- Medical number: 83095053
Old Med : 3603/2022
2-ID number: 26209030101916
Patient Age : 61 Y

DT

0 0

Family history
Phone 01003677321 01145354461
BHI
REASON OF MDT POST OPERATIVE
marital status
NRS Score
GROUP A
Co morbidity HTN CARDIAC (ISCHEMIC) HEPATITIS B
Menopausal status
Date of MDT 03/15/2023

Clinical data

Breast Imaging :			Mets Workup :		
BX: DCIS	ER: STRONG POSITIVE	PR:	Her 2 Neu :	SISH :	Ki67 :
T	N	M			

Sonomammography
RT BREAST (BIRADS 1 NORMAL)
RT BREAST (BIRADS 2 -BENIGN) POST OP.

PATIENT HISTORY
11/2022: TWO RT BREAST MASS EXCISION---HIGHLY GRADE DCIS , MARGIN LESS 1MM
CESM: POST OPERATIVE CHANGES
WLE+SLND: PT0N0
PT ALREADY STARTED PORT
15/3/2023:PT STARTED RTH 12 TH FOR TODAY
IHC AS 1ST SURGERY
HIGH GRADE DCIS
FOR HORMONAL TREATMENT
FOR REMDT

MDT OUTCOME & PLAN

POST CBS DCIS WITH ER STRONG POSITIVE FOR ADJUVANT TAMOXIFEN FOR 5 YEARS

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY		RADIOLOGY	
SURGERY		PATHOLOGY	
Psychiatric		Nutrition	

About blank

Name: جميلة عبدالرحمن عبد العال **MR. :** 2037	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالتها

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انها

The patient presented on 07/02/2026 for a routine assessment and was prescribed arimidex with supportive therapy for a planned three-month duration.

The most recent note from 06/06/2026 indicates that no additional data were available and that the last assessment of the patient on adjuvant arimidex plus supportive therapy occurred in March 2026. The patient remains on the current regimen with no further cycle or week count documented.

تحريرا في ,

التاريخ :	19-09-2026	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : Reham Ahmed Fathy Ibrahim

يعتمد ,

Patient Name	: الأستاذه / جميله عبدالرحمن عبدالعال غنيم	Request No.	: 13006668
Patient No.	: 26207030101946	Request Date	: 07/11/2022
Path No.	: 3346/22	Verification Date	: 05/03/2023
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 60 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc.	:	IHC No.	:
		Registered by	: .marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical data: Two Right breast masses.
Nature of Specimen : Excision

Gross:
Two masses received in a single container, submitted as:
1-Fibrofatty tissue piece (Not marked by sutures) measuring 8x3x1.5 cm, with skin covering: 2x1 cm. Cut section revealed rubbery grsyish white mass measuring 2.5x2x1.5 cm, located 2.5 cm from least resection margin.
2-Fibrofatty tissue piece (Not marked by sutures) measuring 5x3x2 cm, with skin covering: 2x1 cm. Cut section revealed rubbery to firm grsyish white mass measuring 3x2x1.5 cm, located 0.1 cm from least resection margin

Microscopic:
Histopathological examination of sections prepared from specimen (1) received reveals diffuse stromal fibrosis, focal adenosis irregular, cystically dilated ducts, and ducts showing apocrine metaplasia. The ducts are lined by inner columnar and outer myoepithelial cells. There is fibroadenosis, fibroadenomatosis and Focal ductal hyperplasia. Free margins.

Histopathological examination of sections prepared from specimen (2) breast tissue showed dilated ducts flooded with malignant large epithelial cells having marked degree of nuclear anaplasia arranged in solid and comedo pattern with central necrosis with associated fibrocystic changes and microcalcification. No Invasive component detected.
The least surgical margin for the insitu component is less than 1 mm.
ER: Strong positive staining .

Diagnosis:
Two Right breast masses , Excisions ;

Verified by :
dr.esraa magdy

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]

Patient Name	الأستاذه / جميله عبدالرحمن عبدالعال غنيم	Request No.	13006668
Patient No.	26207030101946	Request Date	07/11/2022
Path No.	3346/22	Verification Date	05/03/2023
Sex	Female	Financial Category	اورام دار السلام - تغطية الدولة
Age	60 Y	Department	Out Patient
Referreing Doc.		Registered by	.marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

1- Fibrocystic changes of the breast.
2- High grade DCIS . The least surgical margin for the insitu component is less than 1 mm.
ER: Strong positive staining .

Prof. Manal Elmahdy
Prof. Gamal Abdelaty
Dr. Marwa Mahmoud

Verified by :
dr.esraa magdy

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]

Patient Name	: الأستاذه / جميله عبدالرحمن عبدالعال غنوم	Request No.	: 13002724
Patient No.	: 26207030101946	Request Date	: 08/05/2023
Path No.	: 1334/23	Verification Date	: 20/05/2023
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - فئة الدولة
Age	: 60 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: All mostafa

Pathology Report

Clinical Data: Historty of Breast carcinoma on hormonal therapy, now presented by cervical polyp with endometrial thickening .
Nature of Specimen: Endometrial curettings, D&C .

Gross Examination: Polypoid tissue pieces measuering collectively 5x2 cm .

Microscopic Examination :
Histopatholgical examination of sections prepared from the endometrial curettings received reveals fragments of endomertial polyp formed of large cystically dilated crowded glands , some glands showed focal cytolagic atypia of lining in the form of large vesicular rounded nuclei . The surrounding stroma was fibrous entangling thick walled blooed vessels .

Diagnosis:
Uterus, Endometrial curettings, Picture is that of:
Hyperplastic Endometrial Polyp with focal cytologic atypia .

Dr. Rana Fathy .
Dr. Marwa Mahmoud

Verified by :
Dr.Marwa mahmoud

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Patient Name: Gamila Abd El Rahman Abd El Aal Ghonaim	Date : 14/01/2023
Exam : C.T CHEST	Age : 60 Year(s)
Medical ID:	19221

NON-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST: -

Findings:

- Bilateral pulmonary mosaic attenuation with right basal pulmonary nodule measuring 9 x 5 mm seen at the middle segment of the right lower lung lobe, otherwise clear rest of both lung fields.
- No enlarged hilar or mediastinal lymph nodes, prominent bilateral axillary lymph nodes are noted with preserved fatty hilum.
- No evidence of pleural effusion or masses seen.
- No gross cardiac abnormality. No pericardial effusion detected.
- Normal non-enhanced appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
- Normal appearance of the chest wall.
- Upper abdominal cuts are unremarkable.
- **N.B:**
  - Azygos lobe & fissure noted (variant).
  - ***Enlarged left thyroid lobe with retrosternal extension, for neck U/S assessment.***

OPINION:

No evidence of pulmonary pneumonic consolidations or ground glass patches.

Bilateral pulmonary mosaic attenuation with right basal pulmonary nodule for follow up.

Dr. Nehal diab

Dr. Sherif Sameh, M.D.

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]